

Doppler Fetal — Interpretación

Doppler Fetal — Interpretación

Arterias Evaluadas

TABLA 3.36.1: ARTERIA VS INFORMACIÓN	
ARTERIA	INFORMACIÓN
Arteria umbilical	Resistencia placentaria — principal para RCIU
Arteria cerebral media (ACM)	Vasodilatación cerebral (brain-sparing) = hipoxia crónica
Ducto venoso	Función cardíaca fetal — el más grave si está alterado

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir **Doppler umbilical** (fetal, evalúa RCIU) con **Doppler de arterias uterinas** (materno, predice preeclampsia). Son exámenes con objetivos distintos.

Progresión de Severidad en Arteria Umbilical

TABLA 3.36.2: ESTADO VS DESCRIPCIÓN		
ESTADO	DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD
Normal	Flujo diastólico presente y normal	Normal
Resistencia ↑	IP arteria umbilical > p95	Leve (RCIU tipo 1)
Flujo ausente en diástole	Sin flujo diastólico	Moderado (RCIU tipo 2)
Flujo reverso en diástole	Flujo va en dirección contraria	Grave (RCIU tipo 3)

Ducto Venoso

- **Normal:** onda A positiva

- **Ausente o reverso en onda A → el hallazgo más grave →** RCIU tipo 4

ACM (Arteria Cerebral Media)

- **Vasodilatación cerebral** (brain-sparing): resistencia ↑ en ACM (flujo compensatorio al cerebro)
- Indica hipoxia crónica — el feto prioriza la perfusión cerebral

Doppler de Arterias Uterinas (materno)

- Resistencia ↑ → predictor de preeclampsia
- **No es un Doppler fetal** — no clasifica RCIU
- Su rol es: definir si la paciente necesita aspirina profiláctica y sospechar RCIU vs. PEG cuando hay duda

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Doppler Fetal — Interpretación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Doppler Fetal — Interpretación. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Arterias Evaluadas
- Progresión de Severidad en Arteria Umbilical
- Ducto Venoso
- ACM (Arteria Cerebral Media)
- Doppler de Arterias Uterinas (materno)
- Arteria cerebral media (ACM)
- Doppler de arterias uterinas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DOPPLER FETAL — INTERPRETACIÓN)

PREGUNTA 1

Respecto a Doppler Fetal — Interpretación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A) El diagnóstico de Doppler Fetal — Interpretación se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Doppler Fetal — Interpretación debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Doppler Fetal — Interpretación requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Doppler Fetal — Interpretación es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Doppler Fetal — Interpretación no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Doppler Fetal — Interpretación?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Doppler Fetal — Interpretación. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: DOPPLER FETAL — INTERPRETACIÓN

:::warning No confundir Doppler umbilical (fetal, evalúa RCIU) con Doppler de arterias uterinas (materno, predice preeclampsia). Son exámenes con objetivos distintos. :::